DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: NANCY RENTERIA DE CAICEDO **Identificación** CC 29303786
Edad: 82 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 2 **Fecha programación de cirugía:** 01/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	042314	NEUROLISIS EN NERVIO DE MANO VIA ABIERTA	Y39	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

1	770301	SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO O CUBITO	Y39	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

1	780301	INJERTO ÓSEO EN CÚBITO O RADIO	Y41	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

1	793303	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN SEGMENTO DISTAL DE CUBITO O RADIO CON FIJACION INTERNA	Y40	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

1	819331	CAPSULORRAFIA ARTICULAR EN MUÑECA VIA ABIERTA	Y39	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

1	824203	TENORRAFIA DE FLEXORES DE DEDOS (CADA UNO) SIN NEURORRAFIA	Y45	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

1	828907	RECONSTRUCCION DE LIGAMENTOS EN MANO CON AUTOINJERTO VIA ABIERTA	Y45	

Cirujano: RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MUÑECA DERECHA

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES214 RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ **Especialidad** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

042314 NEUROLISIS EN NERVIO DE MANO VIA ABIERTA
770301 SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO O CUBITO
780301 INJERTO ÓSEO EN CÚBITO O RADIO
793303 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN SEGMENTO DISTAL DE CUBITO O RADIO CON FIJACION INTERNA
819331 CAPSULORRAFIA ARTICULAR EN MUÑECA VIA ABIERTA
824203 TENORRAFIA DE FLEXORES DE DEDOS (CADA UNO) SIN NEURORRAFIA
828907 RECONSTRUCCION DE LIGAMENTOS EN MANO CON AUTOINJERTO VIA ABIERTA

Dx Preoperatorio: S525 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO

Dx Postoperatorio: S525 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** BLOQUEO NERVIO **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 20 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 01/11/26 **Fecha Final** 01/11/26
Hora Inicio 14:00:00 **Hora Final** 15:20:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
VERIFICACIÓN DE LATERALIDAD, CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO, PARADA DE SEGURIDAD, PACIENTE EN POSICIÓN

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

DECUBITO SUPINO, MESA DE MANO, GUIA RADIOLUCIDA, ASEPSIA Y ANTISEPSIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO
VIA 1: INCISION EN PIEL SOBRE TERCIO DISTAL PARA ABORDAJE DE HENRY, DISECCION POR TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO, SE IDENTIFICA TENDON FLEXOR CARPI RADIALIS SE HACE TENOLISIS SE ABRE TECHO Y PISO DEL TENDON, SE ABRE FASCIA DE COMPARTIMIENTO VOLAR PROFUNDO, DISECCION ATRAVES DE FLEXORES, SE ABRE PRONADO CUADRADO EN FORMA LONGITUDINAL, SE EXPONE RADIO DISTAL E IDENTIFICAN HALLAZGOS OPERATORIOS, SE HACE NEUROLISIS PROXIMAL Y DISTAL DE NERVIO MEDIANO SE LIBERA DE SU TRACCION QUEDANDO CON CAMBIOS DE COLORACION, SE HACE SECUESTRECTOMIA DEL FRAGMENTO NO ADHERDIO A TEJIDO BLANDO, - SE HACE FLEXION PALMAR DE MUÑECA SE POSICIONA DISECTOR Y DESIMPACTA METAFISIS - SE FIJA DE FORMA TRANSITORIA CON 1 CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.25 MM
SE COLOCA HUESO RECUPERADO EN FOCO DE DEFECTO DE LA CORTICAL PALMAR COMO AUTOINJERTO OSEO, SE DESBRIDA TEJIDO CAPSULAR NO VITAL SE HACE CAPSULORRAFIA CON PUNTOS TERMINO TERMINALES, LESION LIGAMENTARIA NO REPARABLE DE FORMA PRIMARIA SE TOMA AUTOINJERTO DE FASCIA SE HACE LIGAMENTORRAFIA CON AUTOINJERTO DE RADIOCAPRIANO PALMAR CON PUNTOS TERMINO TERMINALES Y REINSERTA EN EL LAGRIMA PALMAR ATRAVES DE TUNEL OSEO, SE POSICIONA 1 PLACA RADIO DISTAL 2.4 MM DE 2 COLUMNAS VA DERECHA SE ADOSA CON 1 TORNILLO CORTICAL DE 2.4 MM *12 MM SE BROCAN Y PASAN 4 TORNILLOS BLOQUEADOS 2,4 MM EN ESCUDO (18 MM 3 - 14 MM #1) , SE BROCAN Y PASAN 1 TORNLLO BLOQUEADO DE 2.4 *12 MM EN RAMA, SE VERIFICA ADECUADA REDUCCION DE FRACTURA Y POSICION DE IMPLANTE EN FLUOROSCOPIA, SE LAVA HERIDA CON SOLUCION SALINA, SE RECUPERA CABO TENDINOSO DE FLEXOR BRQUIRRADIALIS SE HACE TENORRAFIA CON PUNTOS DE TIPO BUNNEL, PRUEBAS DINAMICAS BALOTEO - SE VERIFICA EN FLUROSCOPIA ADECUADA REDUCCION DE FRACTURA Y POSICION DE IMPLANTE SE SE LAVA CON SSN SE SUTURA POR PLANOS HASTA PIEL, FINALIZA PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES.

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

HALLAZGOS: MUÑECA DERECHSA CON EDEMA Y EQUIMOSIS,
FRACTURA EXTRAARTICULAR DEL RADIO DISTAL CON DESVIACION DORSAL DE 30° IMPACTACION PALMAR - FRAGMENTO DISTAL CONMITO CON PERDIDA OSEA DE 1 CM DE LA ESQUINA CUBITAL PALMAR, FRAGMENTOS OSEOS NO ADHJERIDOS A TEJIDO BLANDO
LESION COMPLETA DEL LIGAMENTO RADIOCARPIANO PALMAR 2 CM CON DESINSERCION - LESION DE CAPSULA PALMAR DE 1 CM
EDEMA Y CAMBIO DE COLORACION DEL NERVIO MEDIANO POR TRACCION
LESION DEL 80% DEL TENDON BRAQUIRRADIALIS

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES131	RUBEN DARIO LIBREROS	ANESTESIOLOGO
MG246	JONATHAN VELEZ ANGULO	AYUDANTE

RONNY WILLIAM SOTO GONZALEZ
Reg. 760310
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

***** FIN DEL REPORTE *****